

LAPORAN ANALISIS KLINIS

Clinical Decision Support System — AI Doctor

Tanggal Cetak: 21 June 2026, 09:35

1. Identitas Pasien

Nama : ruri
Umur / Gender : 23 tahun / Perempuan
Berat / Tinggi : 45.0 kg / 150.0 cm
No. RM : RM-018

2. Anamnesis & Pemeriksaan

Keluhan Utama:

gatal gatal

Gejala Tambahan:

-

Tanda Vital:

-

Hasil Laboratorium:

-

Alergi:

-

3. Hasil Analisis AI

Kemungkinan Diagnosis:

Kemungkinan terbesar adalah tinea corporis (dermatofitosis kulit badan/kurap) yang masih tentatif, berdasarkan keluhan gatal dan foto yang menunjukkan banyak plak/makula eritematosa berbatas cukup tegas, sebagian berbentuk annular dengan skuama halus pada badan. Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan adalah dermatitis numular/eksim, pityriasis rosea, dan reaksi gigitan serangga/papular urticaria. Karena belum ada pemeriksaan langsung dan belum ada kerokan kulit/KOH, diagnosis belum pasti.

Kode ICD-10:

- B35.4 — Tinea corporis
- L30.0 — Nummular dermatitis
- L42 — Pityriasis rosea
- L28.2 — Other prurigo (papular urticaria/gigitan serangga sebagai banding)

Rekomendasi Terapi:

1. Clotrimazole krim 1% — oles tipis pada lesi dan 1-2 cm di sekitarnya — 2 kali sehari — 2-4 minggu; lanjutkan 1 minggu setelah lesi tampak sembuh. Hindari penggunaan bila muncul iritasi

berat.

2. Cetirizine 10 mg oral — 1 kali sehari malam hari bila gatal — 5-7 hari sesuai kebutuhan.

3. Jaga area kulit tetap kering, hindari menggaruk, gunakan pakaian longgar yang menyerap keringat, jangan berbagi handuk/pakaian, mandi setelah berkeringat, dan cuci pakaian/seprai secara teratur.

4. Hindari krim kombinasi yang mengandung steroid tanpa kepastian diagnosis karena dapat memperburuk infeksi jamur (tinea incognito).

5. Pemeriksaan penunjang: kerokan kulit dengan KOH dari tepi lesi berskuama untuk konfirmasi jamur; bila tidak membaik setelah terapi awal 2-4 minggu, pertimbangkan evaluasi dermatologi dan terapi alternatif.

Saran Pemeriksaan Lanjutan:

- Pemeriksaan kerokan kulit dengan KOH 10-20% — untuk mencari hifa jamur dan mengonfirmasi tinea corporis.
- Pemeriksaan fisik dermatologis langsung seluruh tubuh — untuk menilai pola sebaran, batas lesi, skuama, dan mencari lesi khas lain yang mengarah ke pityriasis rosea, dermatitis, atau skabies.
- Evaluasi riwayat paparan — kontak dengan hewan peliharaan, anggota keluarga dengan keluhan serupa, penggunaan pakaian/handuk bersama, dan keringat berlebih untuk membantu etiologi.
- Bila lesi menetap/atipikal — pertimbangkan kultur jamur atau rujukan ke dokter kulit untuk memastikan diagnosis dan menyingkirkan dermatitis/psoriasis.

Tanda Bahaya / Indikasi Rujukan Segera:

Segera periksa/rujuk bila ruam cepat menyebar luas, disertai demam, nyeri hebat, bernanah, bengkak, kulit melepuh, mengenai wajah/mata/kelamin, muncul sesak atau bengkak bibir, atau tidak membaik setelah 2-4 minggu terapi yang sesuai.

Hasil analisis ini hanya sebagai Clinical Decision Support System (CDSS) dan bukan pengganti penilaian klinis dokter. Keputusan medis, diagnosis akhir, dan tata laksana terapi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dokter pemeriksa berdasarkan pemeriksaan langsung.

Dicetak oleh: AI Doctor System | 21 June 2026, 09:35